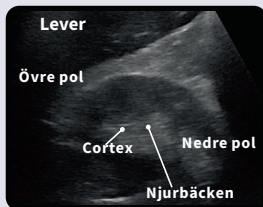


NJURE



Njure längsaxel · hydronefros? sida?

Läge: höger midaxillärt vid arcus, levern som fönster. Vänster: bakre axillarlinjen, högre och mer dorsalt.

Markör: kranialt. Roterat till största längd, tilla genom hela njuren, vrid 90°: njurbäckenet i båda plan.

- Svart i njurbäcken eller calyx? Mörka pyramider är normalt.

HYDRONEFROS



Svara: hydronefros eller inte, och sida. Jämför sidorna: lindrig syns bäst som sidoskillnad. Vid misstänkt uretärsten talar måttlig–uttalad för sten >5 mm. Ingen hydronefros utesluter inte sten. Äldre: aorta?

Liknar hydronefros: kärl i hilus (färgdoppler), parapelvina cystor (hänger inte ihop med njurbäckenet). **Döljs eller överdrivs:** dehydrering döljer; full blåsa och graviditet ger lindrig – upprepa efter vätska eller miktation.

Misstänkt hinder + infektion eller anuri: urolog akut.

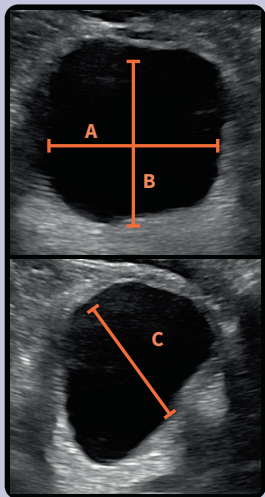


Urinblåsa tvärsnitt · volym? kuff?

Läge: ovanför symfyen i medellinjen, vinkla ner i bäckenet. **Markör:** patientens höger. Svep höger-vänster.

Vrid 90°, markör kranialt: trekantig blåsa, uterus eller prostata bakom och kaudalt. Svep i sidled.

- Fylld blåsa: nästan fyrkantig, ljus förstärkning bakom.
- Tom blåsa: bakom symfyen, faller ihop kring kuffen.



Blåsvolym största innermått, cm

A bredd, **B** djup i tvärsnitt. **C** längd sagittalt.

$V \approx A \times B \times C \times 0,75 \text{ ml}$. Huvudräkning $\times 0,5$ ger en tredjedel lägre. Osäkert <100 och $>800 \text{ ml}$.

Resurin: mät direkt efter miktion.

KAD: kuffen = rund ring i blåsan. Syns inte kuffen är läget inte verifierat. Tom blåsa: försiktigt 50–100 ml NaCl, avbryt vid smärta eller motstånd.

Innehåll: sludge/koagel = blod? Fyller det blåsan: tamponad? Sten ger skugga; utfyllnad utan skugga utreds.

Fallgropar: ascites eller ovarialcysta tas för blåsa. Vätska utanför blåsväggen räknas inte in i volymen. För små mått ger för låg volym.

Volymen avgör inte ensamt åtgärden. Tolka med symtom och lokal handläggning. Ej bedömbart vy är inte normal.